3. 2020N68-69 A 男性，35 岁，反复发作性喘息伴流涕五年，均在每年春季发作。一天前因去花鸟商店后再次发作喘息，较前严重，不能平卧，伴大汗，呼吸困难，意识模糊，来院急诊，诊断为支气管哮喘急性发作期，重度。

端坐呼吸

养鸽子,可以得过敏性肺炎也可以出现支哮
吹空调可以得过敏性肺炎也可以得军团菌肺炎

68.该患者喘息急性发作时的呼吸困难类型是

A.吸气性呼吸困难

B.呼气性呼吸困难 呼气性呼吸困难始终>吸气性呼吸困难

C.混合性呼吸困难 常见于一些换气功能障碍(呼吸面积减少)疾病

D.心源性呼吸困难

嗜睡是最轻的意识障碍,当成重度
↓
先考虑做无创的机械通气

69.该患者此时的动脉血气分析检查结果最可能是

A.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 升高

B.PaO_2 正常，$PaCO_2$ 下降

C.PaO_2 下降，$PaCO_2$ 下降

D.PaO_2 下降，$PaCO_2$ 升高

①气道没有严重梗阻(早期支哮)→PaCO2↓
②气道有明显梗阻(严重支哮)→PaCO2↑

动脉血PO2↓→兴奋外周化学感受器→兴奋呼吸中枢→呼吸加深加快

4. 2021N43 A 男性，23 岁。接触花粉后突发憋喘半小时，家人送至急诊。既往体健。查体：心率 135 次/分，意识模糊，双肺呼吸音明显减低，律齐。在鼻导管吸氧 5L/min 的情况下，查动脉血气分析：pH 7.10，$PaCO_2$ 92mmHg，PaO_2 65mmHg。下一步治疗措施错误的是

A.气管插管机械通气

B.雾化吸入支气管扩张剂 急性发作先舒张

C.静脉应用糖皮质激素

D.静脉应用大剂量利尿剂 严重哮喘→大汗淋漓→补液

5. 2023N42 A 下列提示支气管哮喘重度急性发作的是

A.呼吸频率＞30 次/分

B.日间哮喘症状＞4 次/周 慢性持续期 日夜限缓2

C.双肺散在呼气相哮鸣音 轻度 中重度:弥漫 危重度沉默肺

D.PEF 占预计值 65% <60%

R>30 PEF<60% 心率>120

2. **慢性持续期** 指病人虽然没有哮喘急性发作，但在相当长的时间内仍有不同频度和不同程度的喘息、咳嗽、胸闷等症状，可伴有肺通气功能下降。初始治疗时，可根据白天、夜间哮喘症状出现的频率和肺功能检查结果，将慢性持续期哮喘病情严重程度分为间歇状态、轻度持续、中度持续和重度持续 4 级。目前应用最为广泛的慢性持续期哮喘严重性的评估指标为哮喘控制水平，这种评估方法包括目前临床控制评估和未来风险评估，临床控制又可分为良好控制、部分控制和未控制 3 个等级，具体指标见表 2-4-1。

表 2-4-1 哮喘控制水平的分级

A:哮喘症状控制		哮喘症状控制水平		
		良好控制	部分控制	未控制
过去四周，病人存在：		无	存在 1～2 项	存在 3～4 项
日间哮喘症状>2 次/周	是□ 否□			
夜间因哮喘憋醒	是□ 否□			
使用缓解药次数>2 次/周	是□ 否□			
哮喘引起的活动受限	是□ 否□			
B:未来风险评估(急性发作风险，进展为持续性气流受限，出现药物不良反应)				
与未来不良事件风险增加的相关因素包括： 临床控制不佳；过去一年频繁急性发作；曾因严重哮喘住院；FEV_1 低；血嗜酸性粒细胞计数较高；FeNO 升高；烟草暴露；肥胖；短效 β_2 受体激动剂（SABA）使用率高、ICS 使用不足；频繁使用口服激素、长期高剂量 ICS 使用				

哮喘症状控制的评估指标：
①日间哮喘症状＞2 次/周
②夜间因哮喘憋醒
③哮喘引起的活动受限
④使用缓解药＞2 次/周

无→良好控制
存在 1-2 项→部分控制
存在 3-4 项→未控制

(日夜限缓 2)

答案:3-5 BD D A